



Kết quả tạo hình hộp sọ bằng phương pháp kéo giãn phức hợp trán – ổ mắt (FOD) trên bệnh nhân dính khớp trán – đỉnh một bên

1. TS Đặng Hoàng Thơm – Trưởng Khoa Sọ mặt và Tạo hình Bệnh viện Nhi Trung ương
2. BSNT Cao Khôi Nguyên – Đại học Y Hà Nội

Tận tâm - Chất lượng
Vì sức khỏe Trẻ em Việt Nam



Hotline: 0865 879 879



18/879 La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội



benhviennhitrunguong.gov.vn



facebook.com/bvnhitrunguong

DÍNH KHỚP TRÁN – ĐỈNH MỘT BÊN (UCS)

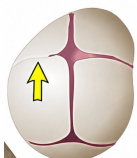
• Định nghĩa – Dịch tễ – Nguyên nhân •



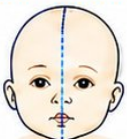
1. ĐỊNH NGHĨA



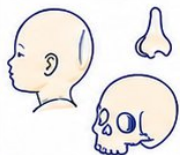
- Bất thường bẩm sinh hiếm gặp vùng sọ mặt



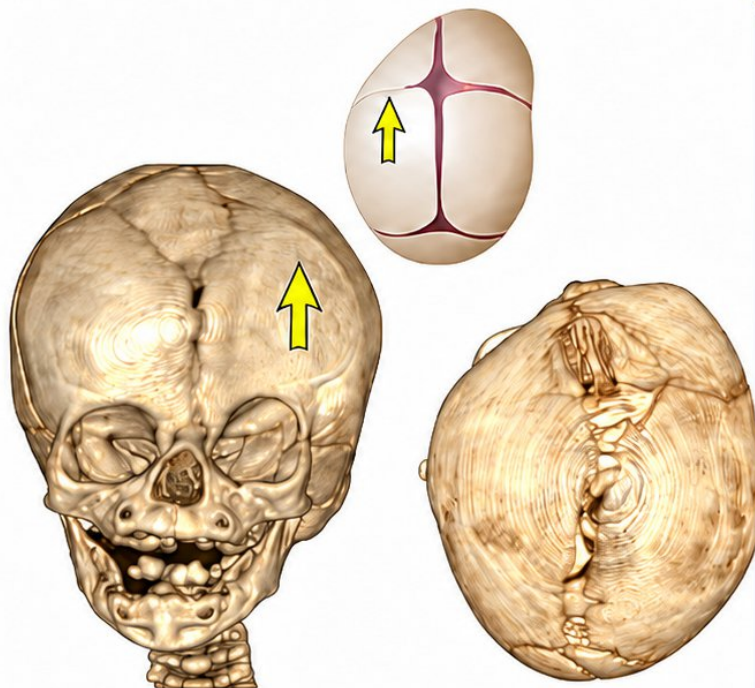
- Dính liền sớm khớp sọ trán – đỉnh một bên



- Đặc trưng: lồng trán cùng bên, lồng trán bên đối diện



- Có thể: đầu bẹt phía trước, mũi lệch, mắt cân xứng hốc mắt



2. DỊCH TỄ



- Thường gặp thứ hai sau dính khớp liên đỉnh



- Tỷ lệ mắc: 1/15.000 trẻ sinh ra còn sống



1/15.000



3. NGUYÊN NHÂN



Chưa rõ – đa yếu tố



~30% liên quan đột biến gen

FGFR2-3

TWIST

EFNB1



Yếu tố gia đình / hội chứng



Hạn chế trong tử cung (con so, đa thai, thai nhỏ)



Nhảy sấm khi sinh



Sinh non

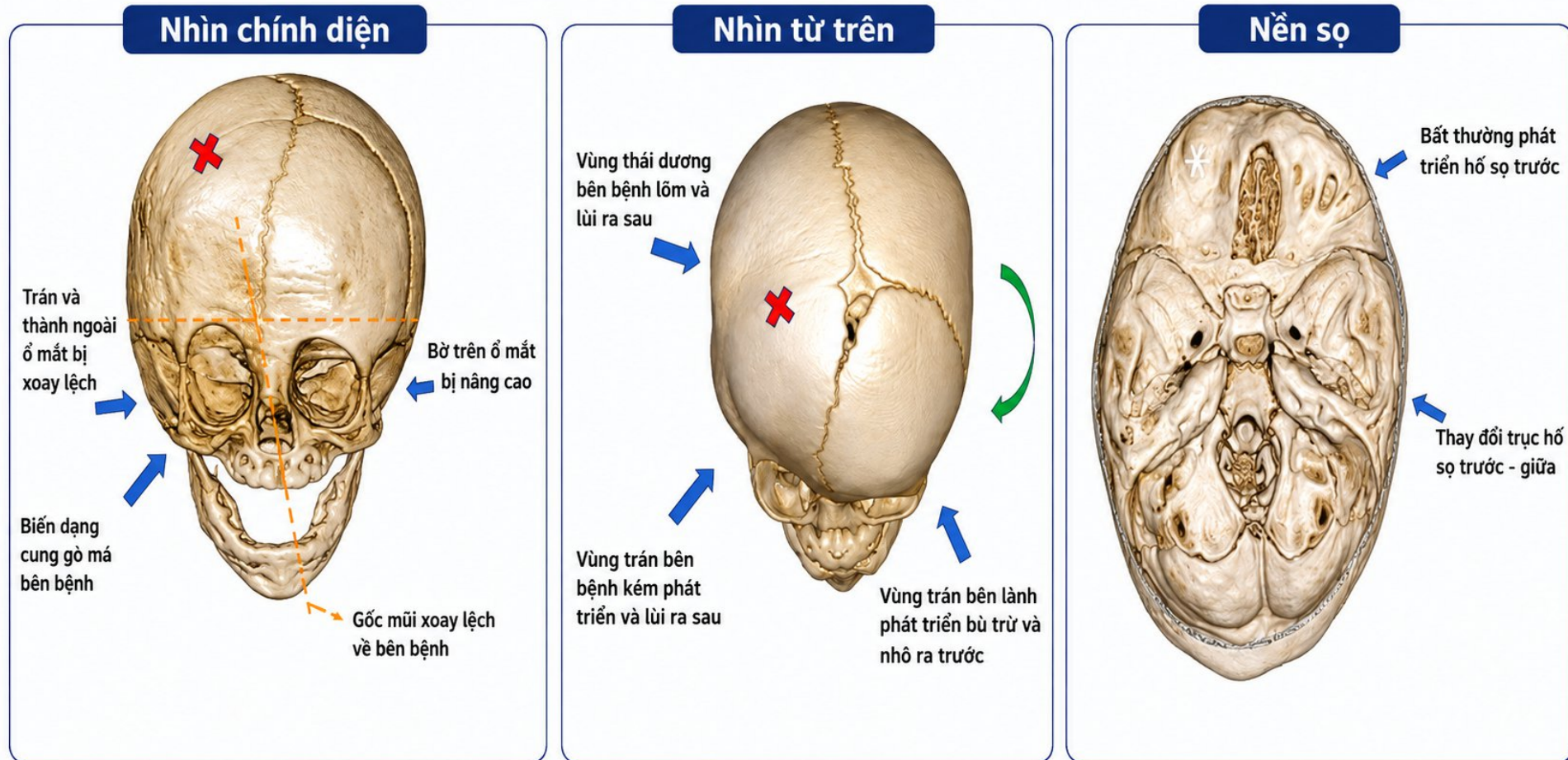


Dùng Valproate khi mang thai

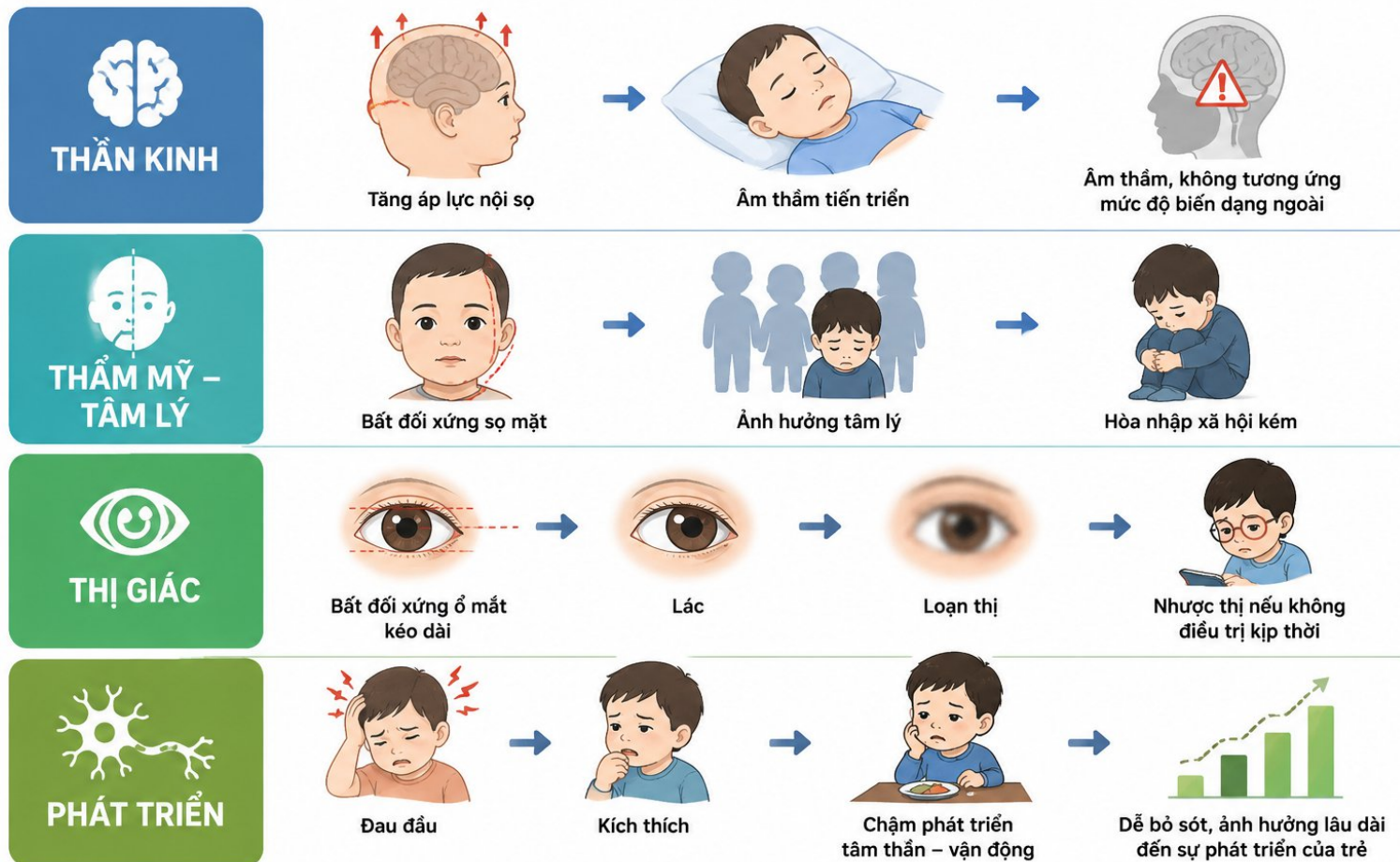


Não ứn thủy cổ đặt shunt

Biến dạng sọ mặt trong UCS

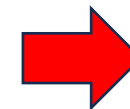
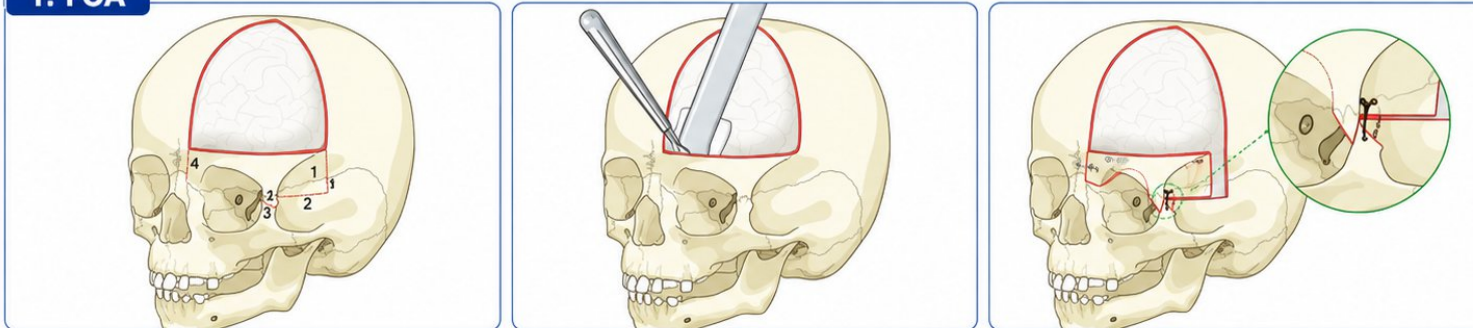


HẬU QUẢ NẾU KHÔNG ĐIỀU TRỊ KỊP THỜI



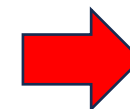
Các phương pháp phẫu thuật cho UCS

1. FOA



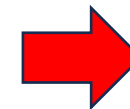
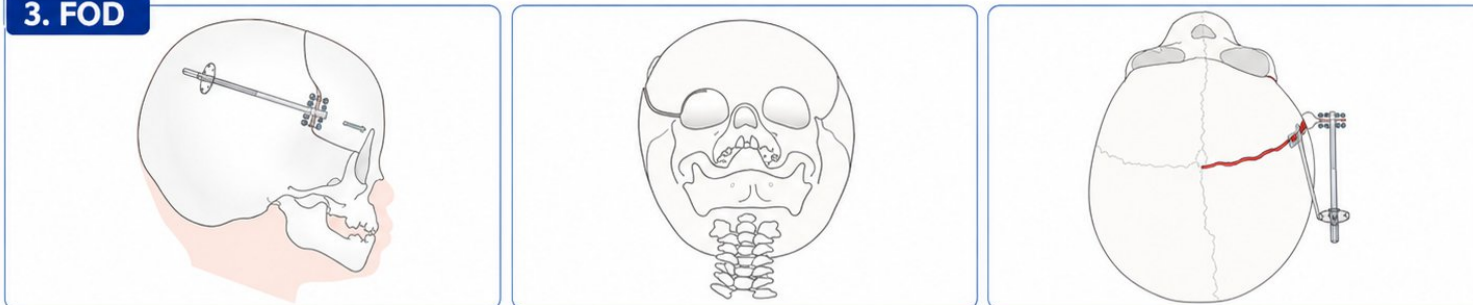
Tiêu chuẩn vàng
trước đây

2. Nội soi cắt khớp + đội mũ chỉnh hình



Chỉ định ở giai đoạn
sớm

3. FOD



Kéo giãn từ từ, có
kiểm soát, điều
chỉnh biến dạng tốt
hơn

Đối tượng và thiết kế nghiên cứu

Tiêu chuẩn lựa chọn

01

Tuổi 5-11 tháng

Giai đoạn can thiệp sớm

02

Dính khớp trán đỉnh 1 bên đơn thuần

Không kèm dính khớp khác

03

Không giãn não thất

Không có thêm bất thường đường khớp sọ

ĐỐI TƯỢNG

15 bệnh nhân

Dính khớp trán đỉnh một bên đơn thuần

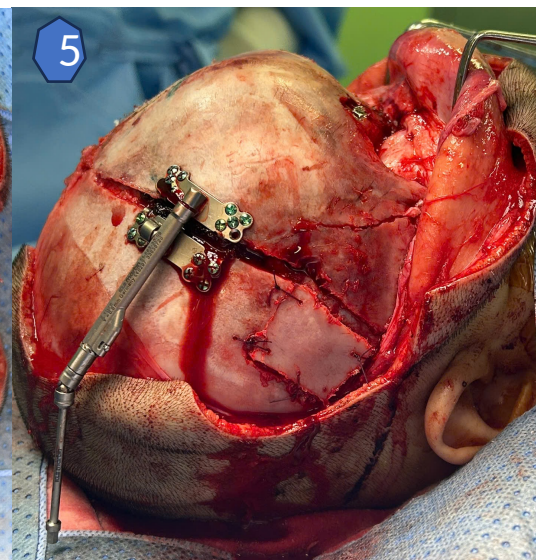
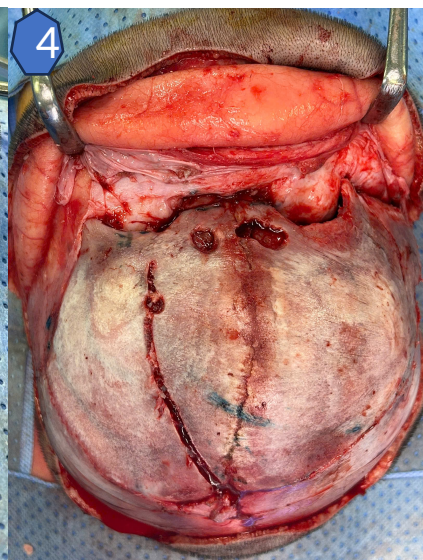
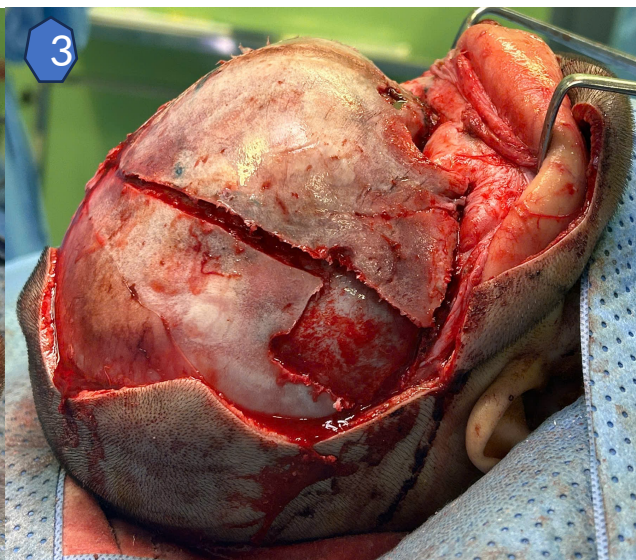
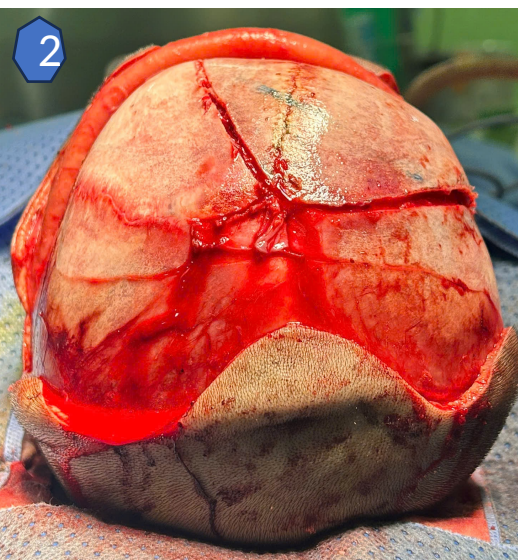
Khoa Sọ mặt & Tạo hình
Bệnh viện Nhi Trung ương

2022-2026

Quy trình nghiên cứu và lịch theo dõi



ĐƯỜNG CẮT XƯƠNG CẢI TIẾN



1. Điểm chuyển tiếp

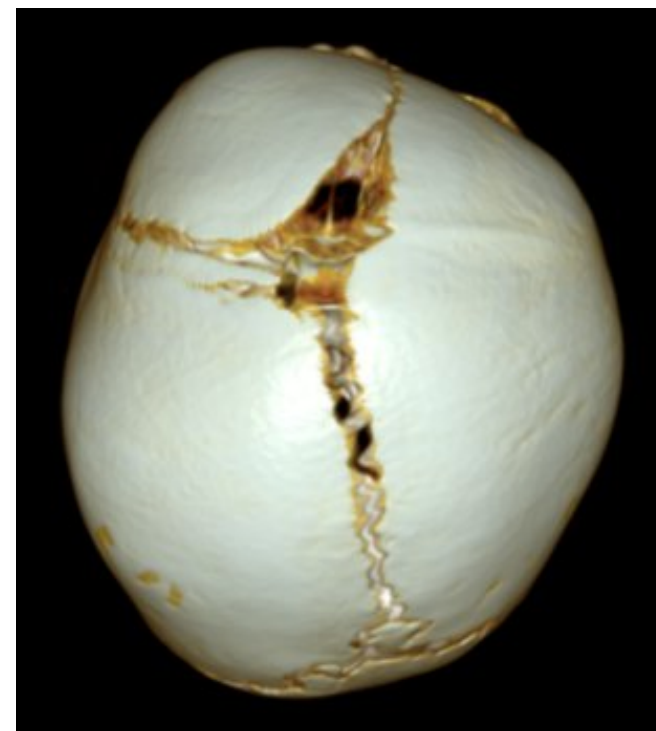
2. Cửa sổ xương

3. Bản lề xương

4. Vecto kéo giãn

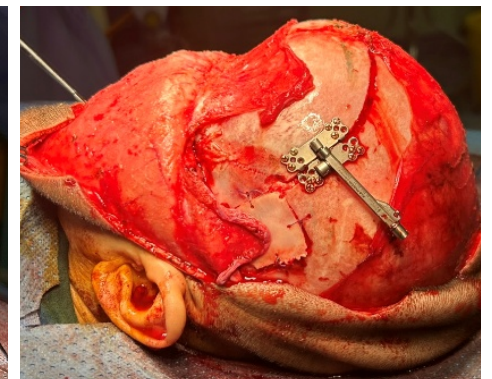
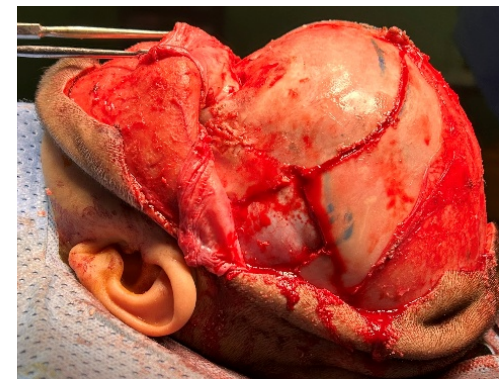
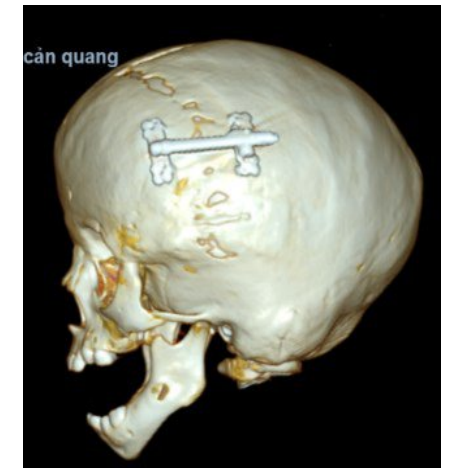
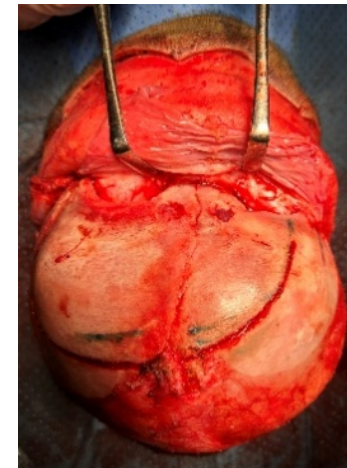
KẾT QUẢ

Đặc điểm lâm sàng	Số BN	Tỷ lệ %
Đầu méo phía trước, sang bên	15	100
Trán phẳng bên bệnh, trán nhô bên lành	15	100
Sống mũi lệch	15	100
Tăng áp lực nội sọ	7	46,67
Hốc mắt bên bệnh nâng cao	15	100
Lõm vùng thái dương	11	73,33
Đầu nghiêng cùng bên	9	86,67
Tai cùng bên đẩy ra trước	8	53,33



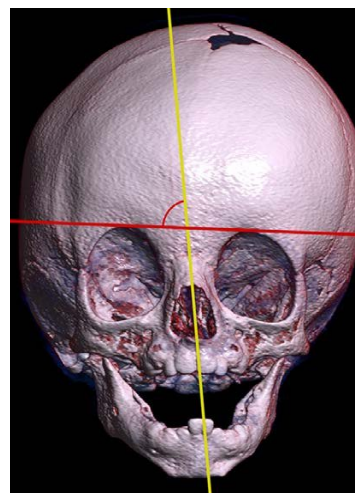
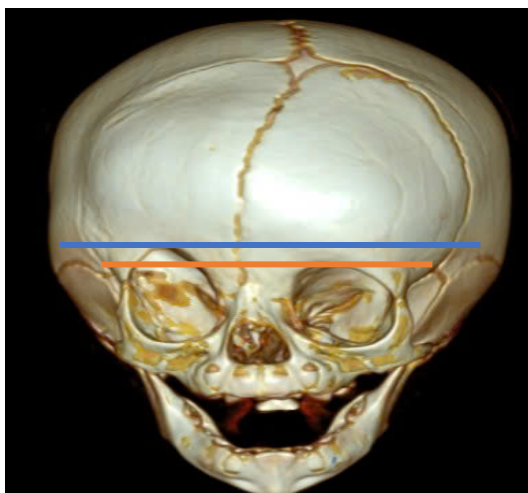
KẾT QUẢ

Đặc điểm	Trung bình
Tuổi mổ (tháng)	$6,4 \pm 3,2$
Cân nặng khi mổ (kg)	$6,81 \pm 2,52$
Thời gian mổ (phút)	$120,1 \pm 24,5$
Thời gian nằm viện (ngày)	$30,4 \pm 2,5$
Khoảng cách kéo giãn thu được (mm)	$26,25 \pm 2,21$
Góc quay mở ra trước của vạt xương trán (độ)	$20 \pm 3,7$



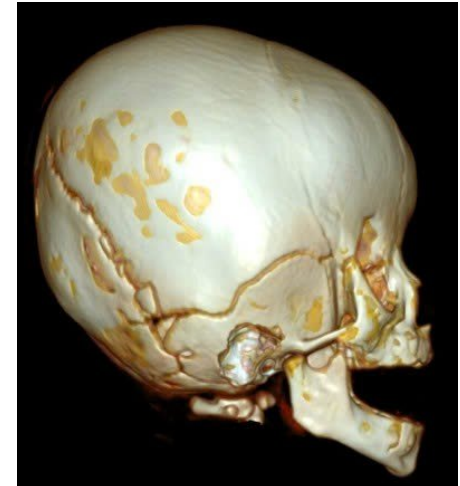
KẾT QUẢ

Các chỉ số	Trước mổ	Khi tháo dụng cụ	Sau 1 năm
Chênh lệch trần ổ mắt 2 bên (mm)	$6,18 \pm 2,51$	$1,03 \pm 0,65$	$1,19 \pm 0,69$
Chênh lệch góc mũi trán ổ mắt (độ)	$8,7 \pm 2,1$	$1,4 \pm 1,2$	$1,2 \pm 0,4$
Khoảng cách lùi sau xương trán (mm)	$9,23 \pm 1,75$	$1,09 \pm 0,11$	$1,05 \pm 0,32$

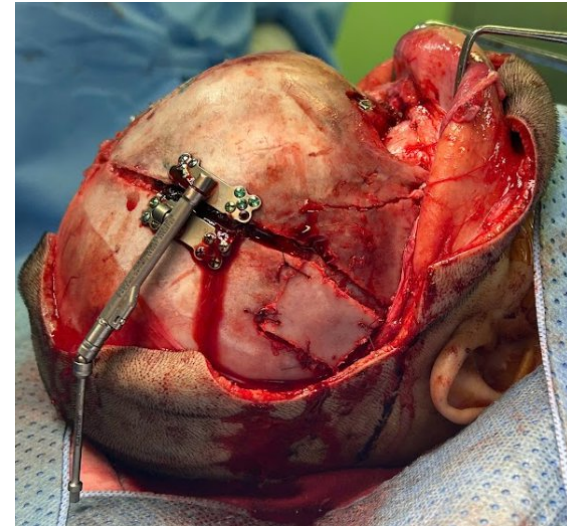
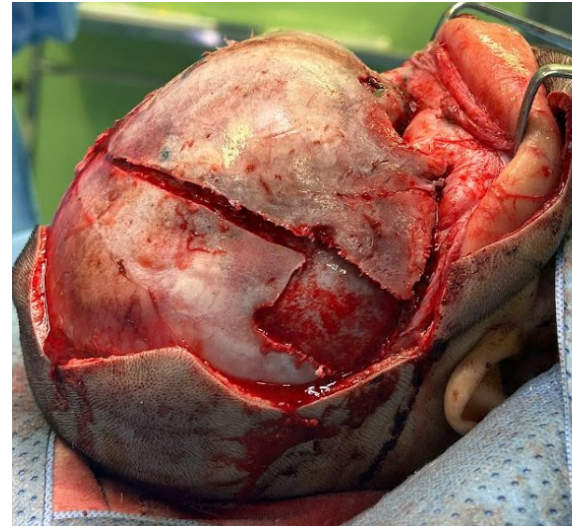
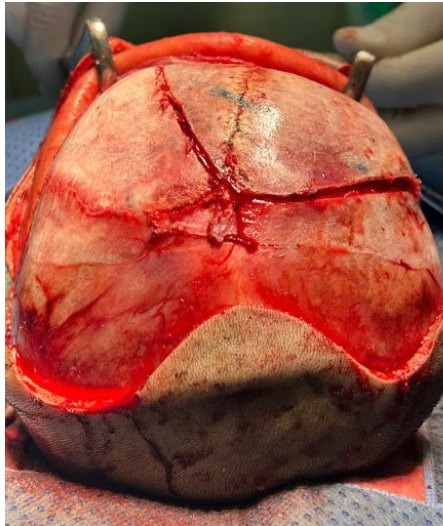
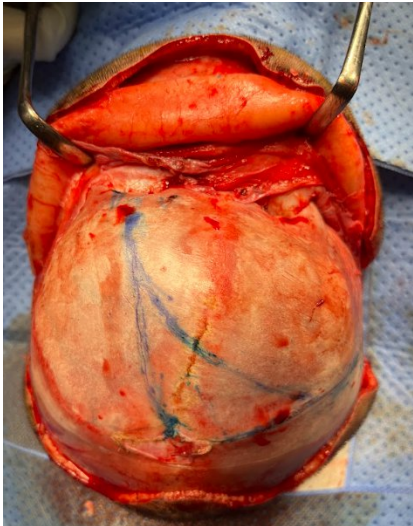


Bệnh nhân số 1

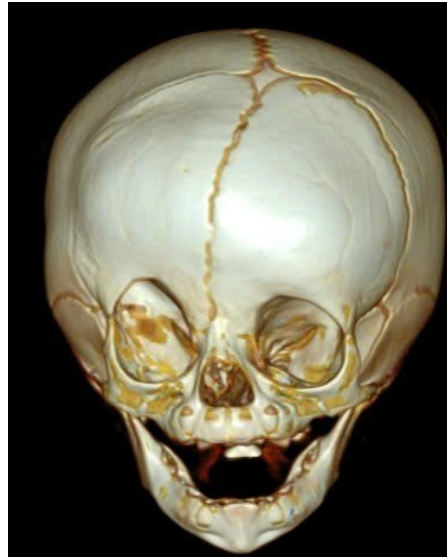
Trước mổ



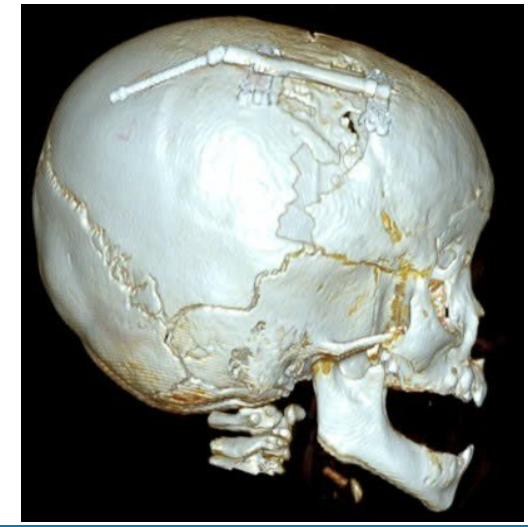
Trong mổ



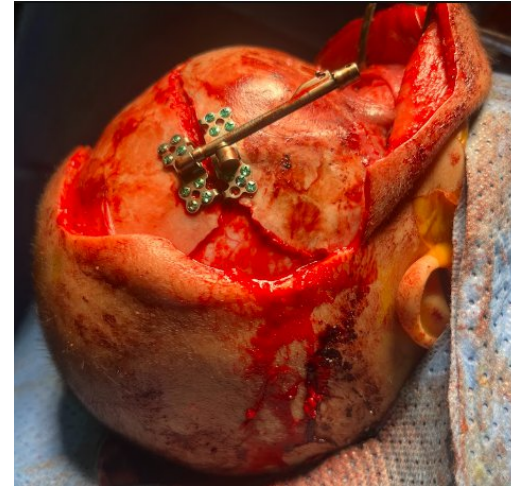
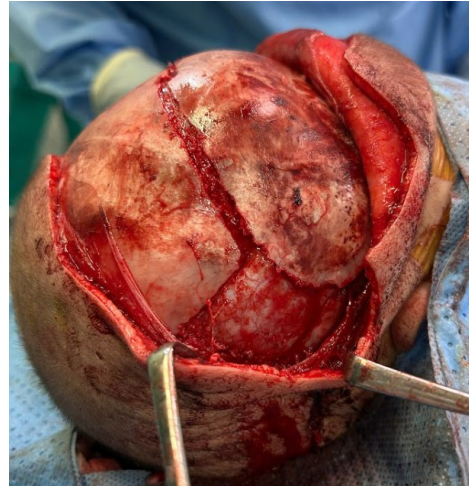
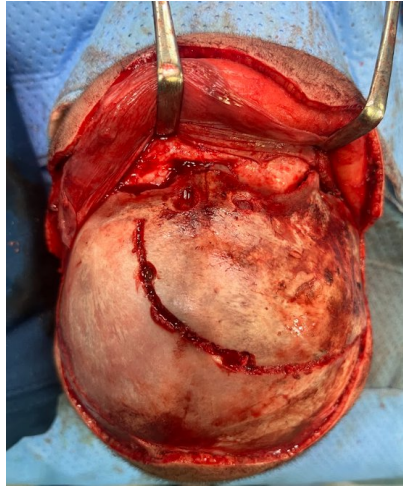
Trước mổ



Tháo dụng cụ



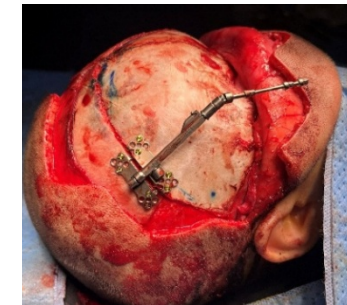
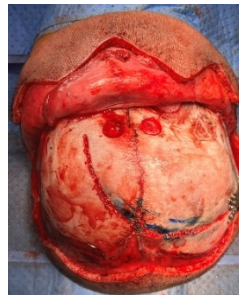
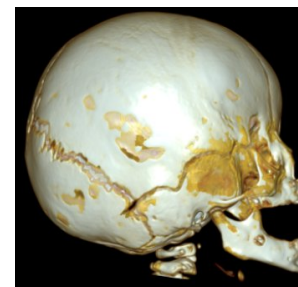
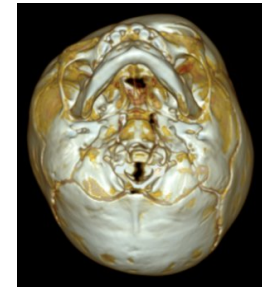
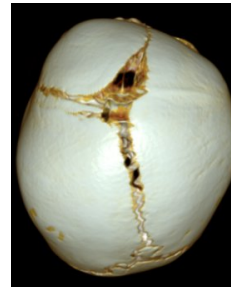
Bệnh nhân số 2



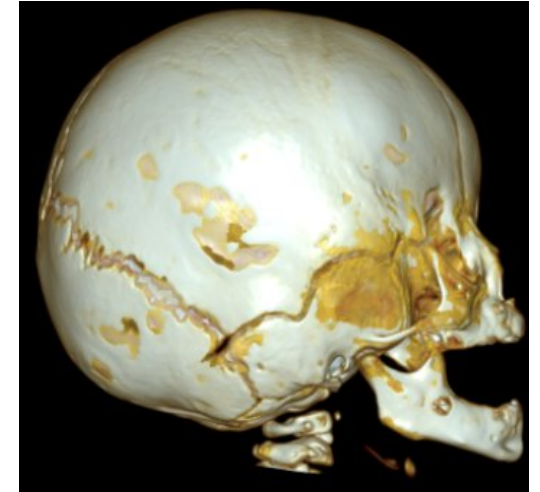
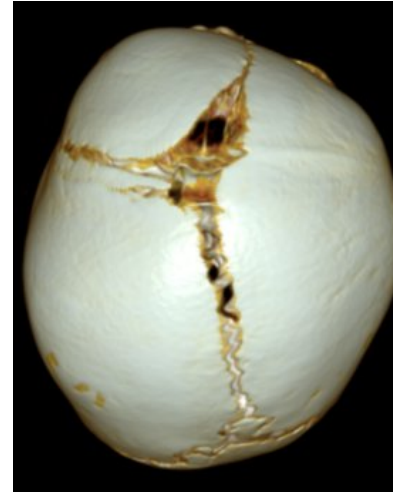
Bệnh nhân số 3

Trước mổ

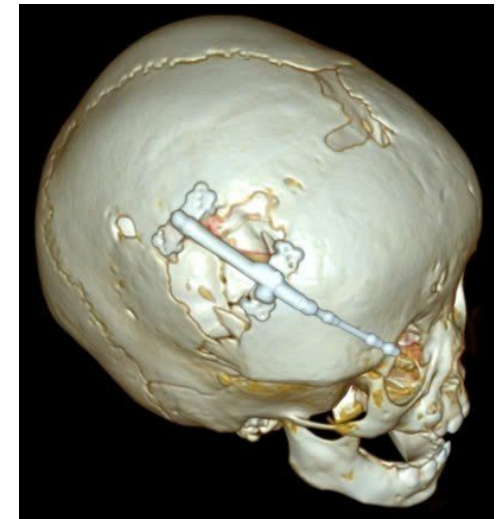
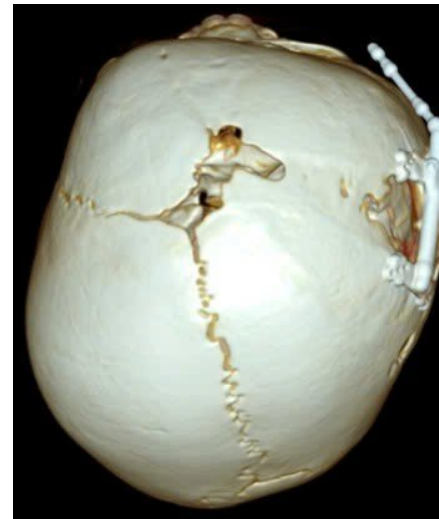
Trong mổ



Trước mổ

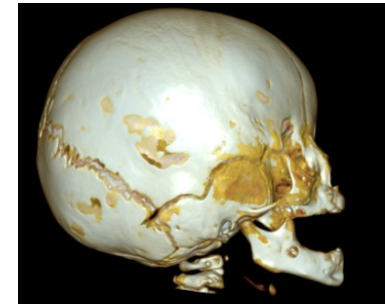
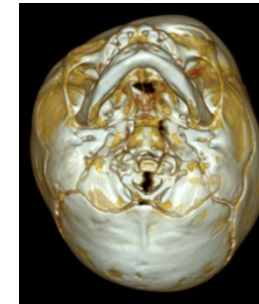
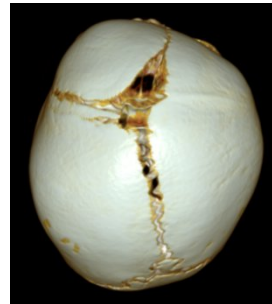
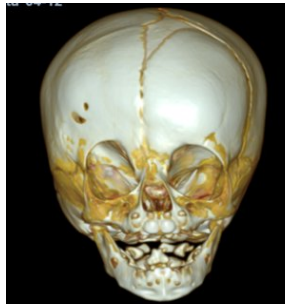


Tháo dụng cụ

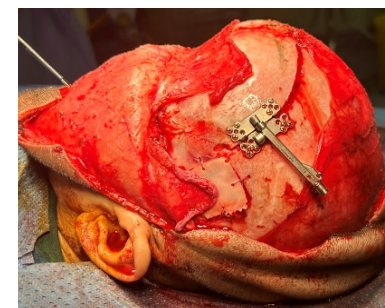
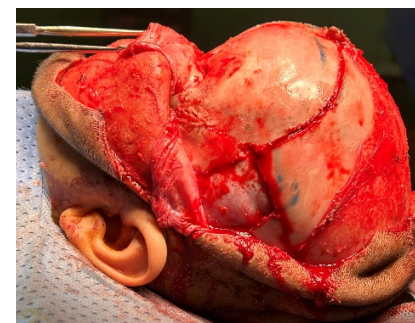
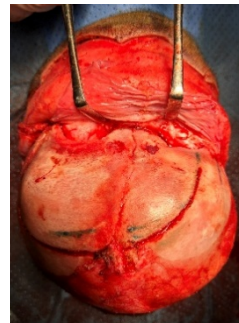


Bệnh nhân số 4

Trước mổ



Trong mổ



Tháo dụng cụ

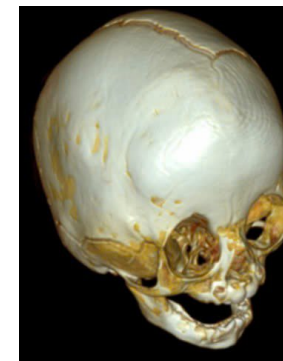


Sau mổ 1 năm

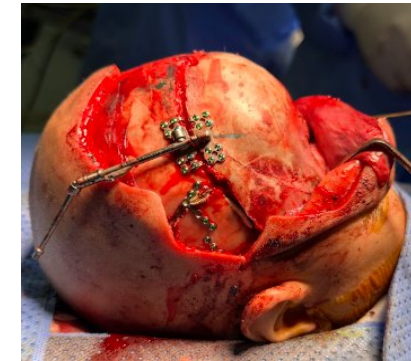
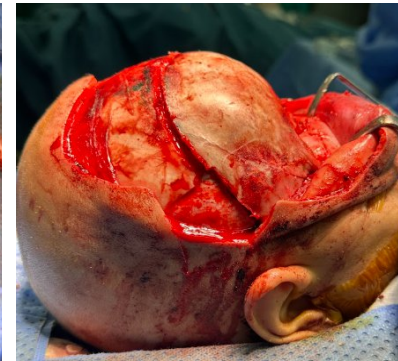
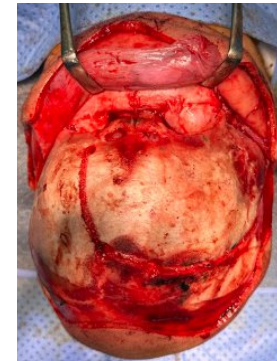
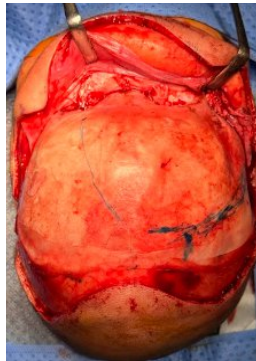


Bệnh nhân số 5

Trước mổ



Trong mổ



Tháo dụng cụ



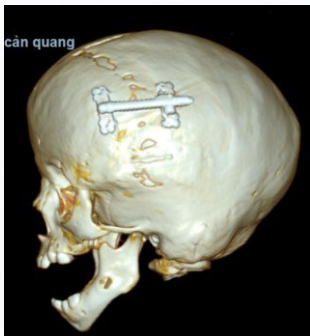
KẾT LUẬN

FOD điều trị dính khớp trán đỉnh một bên

1. TRƯỚC ĐIỀU TRỊ



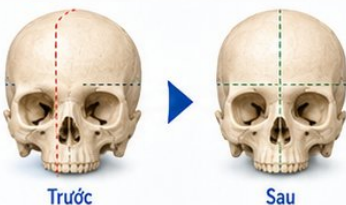
2. FOD - Kéo dẫn kiểm soát



3. SAU ĐIỀU TRỊ



1 Cải thiện đối xứng



2 Thẩm mỹ + chức năng



3 Ít xâm lấn • an toàn • hiệu quả



4 Trung tâm chuyên sâu



FOD: lựa chọn hiệu quả, bền vững cho UCS

**Xin cảm ơn Thầy Cô
và các anh chị đồng nghiệp
đã chú ý lắng nghe**

